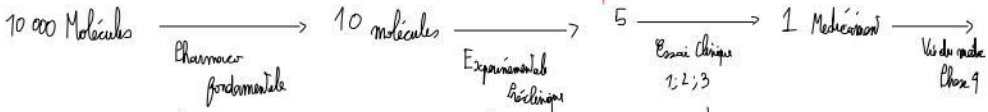


Étude Pré-clinique



Rentable?
Besoin médical?

PD: comprendre le mécanisme

Guidage moléculaire + Pharmacovigilance
ciblée $\rightarrow$ moléculaire / ciblé?

PD / PK / Toxicité

Atome

Conformation

Tox Aigu / chronique / génotoxicité / neurotoxicité / cancéro

2 Espèces différentes: sauvage / non sauvage

Thalidomide: Hypertension / Anti nausée
Cholestérol

Galerique (formulation / pKa / solubilité / absorption)

Voie Entérale / Parentérale / Locale

Scale up chimique: Tox & à grande échelle

Phase 1: Tolérance au médicament

L Volontaire Sain avec critères inclusion

L Exposition croisée

L 1/20 dose max aigu autorisé
... Tox & "PK"

Phase 2: Schéma thérapeutique optimal

L Patient très homogène

L Exposition croisée

L Tolérance (2x) $\rightarrow$ EFFICACITÉ (2x)

phases

phases

Dose-effet / EI / PK / PD

Phase 3: Efficacité thérapeutique (efficacité réelle à long terme)

L + + + Patient

L Long Termes (efficacité à long terme)

Méthodologie des essais cliniques

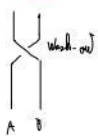
Contrôle

Comparatif

Randomisé = Tir au sort & biais de sélection

"Gros-Etats" croisés

Parallèle



Médecin vs
Médecin différent

Médecin vs
Placebo

Médecin contrôlé

Médecin contrôlé

1 seul contrôle

+ diversifier patient

Clonaz

Insu

double Insu

Médecin

Patient

Suivi

Suivi

Suivi

No suivi

No Suivi

No Suivi

Phase 4 (étude clinique) = Pharmacovigilance

EI = réaction à mon traitement

Effet 2nd = non voulu, pas forcément nocif (allergie à antibiotique)

"Evénement" = la bête

- EI grave (prostate vitél / hépatite / urticaire permanente / décès)
- EI moyen
- EI mineur

Pharmacovigilance = EI

Adverse Vigilance = défenses (surveillance) / tolérance

Vigilance → Carie = Ligne

Thalidomide / Distillat

Vaccin : ANIS → Risque cardiaque

Médicament : AFSSAPS → ANSM

Vaccin de Souches : Anticorps → Tétracycline

modèles
pharmaco
dynamique
système

Signalement OBLIGATOIRE (Sous Notif = qualitative MAIS PAS quantitative)

Score imputabilité

Score Intrinsèque (I₀ → I₆)

Chronologie (C0 → C3) : Année d'écoulement

Sémiologie (S0 → S3) : effet compatible avec les propriétés du médicament

Score Extrinsèque → Bibliographie (B₁ → B₄)

EI amplifié

... dans les RCP

Déclat appétit (challenge)

- Suggestif : Positif
- Compatible : Long
- Non-convaincant : impossible à interpréter (médicament / malade)
- Non-Suggestif : Incertain

Evénement P.J. / Médicament (désordre)

- Positif : suspect EI
- Négatif : EI 2nd / 3rd
- Non-convaincant

Re-challenge

- Positif : Répétition EI
- Négatif : Pas de récurrence
- Non-convaincant

EI laboratoire

EMA

PRAC

CHMP

CMD

30 CRPV → ANSM → Evénement Vigilance
BNPV Vigilance